mostly weekly **Bermudas Times** No. 982 on 18 June, 2016

B軍、KSSCに大勝。舛添野球？の称賛　オーシャン連敗脱出の二連勝。

徳光関　本盗披露するもトホホ　ＦＴつき指

2016年 6月 18日16:00-18:00 横浜市営岡野公園球場　オーシャンリーグ公式戦 第 6戦

	1	2	3	4	5	6	7	R	H
KSSC 2001	0	0	0	1	2	0	0	3	1
Bermudas	8	4	1	0	1	4	X	18	13

勝投手:三橋、負投手:松崎(K)
二塁打:井上宗、緒方、大島(B)

【2016年6月18日　横浜市営岡野公園球場発／
内山編集長、徳光記者･ビデオスタジオ】

センテンススプリングによる毎週の執拗な追及特集記事にも、ワシントンポストにSEKOIと失笑の揶揄をうけても、都議会のヤジ入り集中審議や辞職決議案にも屈せずオリンピックへの歴史に名を残そうと都知事の職に居座り続けた舛添前知事の執着力に例えて、平均年齢60歳前後のB軍が20歳代の若手チームKSSCへの戦いぶりを舛添野球と評した主審のゲームセットの挨拶は的外れであったが、何処か共感を得るものだった。大量点差となっても、果敢に次の塁をチャレンジする姿勢が感動を伝えたのだ。

井出副監督　講評

皆様　お疲れ様でした。本日の試合も大勝でした。しかし内容は粗くならずに常に目的をもって攻めることができました。走塁を重視した効果だと思います。 酷暑の中、11人全員打ちでのぞみましたが、私は途中暑さと疲労で相当具合が悪くなりました。 ケガなどのリスクを考えると一人はベンチに残したほうが危機管理としては正解だったかもしれません。 以下、試合を振り返ってみたいと思います。

【攻撃】 今日の試合前に積極的な走塁を課題に挙げました。もっと一次、二次ともリードをとれると思います。徳光選手の自己判断の３盗、本盗は、スタート、スライディングもよく見習うべき走塁だったと思います。**走塁面から試合を振り返ってみましょう。**走ることで筋力もついてきます。

初回は、相手のミスにつけこみ８点を挙げました。ほとんどが盗塁、エンドラン、ランナー３塁からのエンドラン、スクイズなどランナーを動かしてあげたものです。 その後もサインを出し続けました。意外な場面でのサインでかなり混乱したかと思いますが、サインを見る習慣をつけて頂く、という狙いもありました。 ランナー２塁、或は３塁からのエンドランは、今後の攻撃のバリエーションとして磨き上げたいと思います。

１、３塁のケースが何度かありました。このケースは通常１塁ランナーがフリーパスとなりますが、今日は２回刺され、１回は挟殺プレーとなりました。相手をなめずにきっちりとした走塁、打者のサポートが必要ということです。また、試合後井上コーチより、「キャッチャーが二塁にのびのびと投げられるのは３塁ランナーにホームを狙う構えがないからでは、」との指摘がありました。もっともなご指摘と思います。３塁ランナーは投手或はセカンドのカット ～ ３塁転送に気を付けながら、できるだけ野手の注意をひきつけ、着実に２，３塁を作れるようにしましょう。２塁上でボールがこぼれることが多いので、本塁への意識も忘れずに。

また、１，３塁で１塁走者が挟まれている間の３塁ランナーは、しっかりとホームへの意識を相手に見せていきましょう。あの場面では走塁次第で１点を奪えたらいいですね。

また私が２塁ランナーでヒットでホームを狙った際、レフトからの好返球でアウトになりました。この場合、次打者が本塁後ろでスライディングの方向を教えるのがセオリーです。いずれ、そういうことができるチームを目指しましょう！

今日は、走塁は、走者同志、あるいは打者の連携であるということを実感できた試合でした。

【バッテリー／守備】 暑さもあり３投手の継投を最初から考えていました。また、投手が変わる際の守備の変更にも慣れていただきたいと考えていました。 今後もしばらくこのような展開を続けてみたいと思います。 捕手として受けていて皆コントロールが非常によかったことに驚きました。緒方投手も途中でしっかり修正ができていました。 エラーがいくつかありました。点差が開いたため目立ちませんでしたが、Ｂ軍の生命線ですので、練習を重ねましょう。個人練習のお申し出もお待ちしています。

【今後】 次戦は,初顔合わせのチームです。相手に合わせず、自分たちの野球をのびのびとやり抜きましょう。

三橋
V投手

投手成績	投手名	回数	打者	安打	四死	三振	失点	自責	投球	勝敗S	防御率
Kssc 2001	●松崎	4	31	9	7	3	13	3	100		
	半谷	2	12	4	3	3	5	4	62		
Bermudas	建部	3	10	1	0	3	0	0	34	1-2-0	3.00
	緒方	2	12	0	3	3	3	1	44	0-0-0	14.00
	◎三橋	2	7	0	0	2	0	0	17	1-2-0	2.92

今回の試合の勝ち投手は三橋さんになります。7回まで試合をしているので、先発投手は4回終了まで投げないと、勝ち投手になりません。そうすると、2番手以降の投手が勝ち投手と なりますが、緒方・三橋の両投手とも2回ずつを投げ、三橋さんは無失点ですので、内容の良い三橋さんが勝投手となります。

打順	位置	Kssc 2001	席	数	得	安	点	盗	犠	球	振	残		
1	C	上野	4	3	1			2		1		1		
2	CF	小澤	4	3	2			1		1	2			
3	3B	白仁	3	2						1	2			
4	P, 1B	松崎	3	3								1		
5	LF	田島	3	3							2	1		
6	RF	川口	3	3								2		
7	2B	深沢	3	3							1			
8	1B, P	半谷	3	3		1					1			
9	SS	山口	3	3										
		合　計	29	26	3	1	0	3	0	3	8	5		

監督：山口

1　回	2　回	3　回	4　回	5　回	6　回	7　回
二ゴロ		二飛		死球		三ゴロ失
三振			四球	三ゴロ失		三振
三振			三振	四球		
	投飛		三ゴロ失	三ゴロ		
	三飛		振り逃げ		三振	
	中飛失		三ゴロ		捕ゴロ	
	三振		二ゴロ		一邪飛	
		左安打		三振		投ゴロ
		三ゴロ		三ゴロ		二ゴロ
0	0	0	1	2	0	0

打順	位置	Bermudas	席	数	得	安	点	盗	犠	球	振	残	打率	順位
1	LF	大橋貴	4	2	1	1		3		2	1	1	0.286	
2	1B, 2B	湧谷	4	4	1			1			1		0.200	9
3	CF	井上宗	4	4	2	2	2	2			1		0.308	5
4	C	井出	4	4	3	3	1	2					0.560	1
5	DH, RF	徳光	4	2	2	2		2		2		1	0.313	4
6	2B,3B,SS	黒木	4	2	2			1		2	1		0.143	11
7	SS, P	三橋	4	3	3		1	2		1	1		0.250	7
8	3B,P,3B	緒方	4	3	2	2		1		1		1	0.222	8
9	P, 1B	建部	4	2	1	1		1		2		1	0.400	2
10	RF, DH	大島	4	4	1	2	1	1			1	2	0.182	10
11	DH	塩瀬	3	2			1		1			1	0.000	
		合　計	43	32	18	13	6	16	1	10	6	7	0.260	

監督：井出

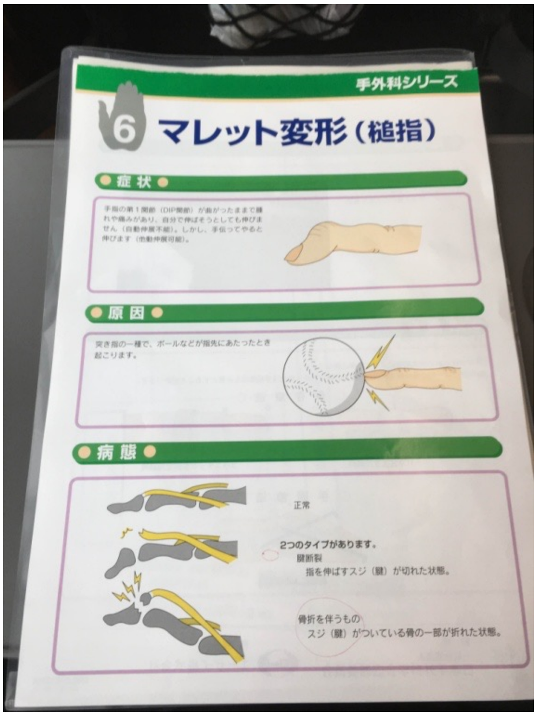
1　回		2　回	3　回	4　回	5　回	6　回
四球	死球		中安打		三振	
三ゴロ失	三振		投ゴロ		投ゴロ	
左2塁打		三振	投ゴロ		中安打	
三ゴロ失		中安打	中安打			右安打
遊内安打		四球	中安打			四球
四球		遊ゴロ二封		四球		三振
遊ゴロ野選		右飛失		三振		四球
一邪飛		四球		右中2塁打		中安打
投ゴロ失		右安打		死球		四球
三ゴロ失		二内安打			左2塁打	三振
投犠打		一飛			三ゴロ失	
8		4	1	0	1	4

＊打撃成績順位は、規定打席到達選手が対象（試合数（11試合）×１．３＝14．３→15打席以上）

トホホ、徳光関ジョッブス博士の手術？

先週のKSSC戦前の練習中に右手中指と薬指を突き指。ETの指のように真っ赤に腫れ上がった薬指もようやく痛みは治まったが、中指先が曲がったままになった。気になったので2日後、本牧の病院にてレントゲン見てもらった。マレット変形（槌指）と診断。腱が小骨と一緒に外れていることがわかった。すぐに関内近くの専門病院を紹介され向かうとX線撮り直し。小骨がついた腱が離れたところにあるので、自然では戻らない。突き指した時点ですぐ病院行くべきだったのか。

当初、手術して金具で串刺しにして、離れた骨同士をくっつけるというドクターの意見だったが、小骨があまりにも小さいため接着は難しく、指逆反り装具を2ヶ月間装着して指先曲がりをもとに戻すという第2オピニオンに賛成して、手術を回避したのであった。**“野球も続けたいんでしょ？”**という ジョッブス博士は草野球を愛する横浜DeNAいやバミューダズのホームドクターに違いない。



手外科シリーズ

6 マレット変形（槌指）

症状

手指の第１関節（DIP関節）が曲がったままで腫れや痛みがあり、自分で伸ばそうとしても伸びません（自動伸展不能）。しかし、手伝ってやると伸びます（他動伸展可能）。

原因

突き指の一種で、ボールなどが指先にあたったとき起こります。

病態

正常

2つのタイプがあります。

腱断裂
指を伸ばすスジ（腱）が切れた状態。

骨折を伴うもの
スジ（腱）がついている骨の一部が折れた状態。